중증 약물이상반응
DRESS · SJS/TEN

발생 시점·장기 침범·표피 박리에서 즉시 중단과 의뢰까지

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

발진이 생긴 날짜를 약물 노출의 시간축에 놓는다

즉시형과 지연형 반응은 출발점이 다르다

DRESS

약물 투여 2~8주 후 발열·발진·내부장기 침범으로 나타난다. 약을 이미 중단했더라도 악화될 수 있다.

SJS / TEN

약물 노출 4~30일 후 급성 피부점막반응. 발열·인후통 등 비특이 전구 증상 뒤 급격히 퍼진다.

아나필락시스

대개 약물 투여 30분 내 발생한다. 전신 두드러기·맥관부종과 호흡·순환 이상을 연결한다.



진단과 평가의 연결

임상 소견을 연결한 도식

설명 도식 · 즉시형과 지연형 반응은 출발점이 다르다

임상 연결 · 즉시형과 지연형 반응은 출발점이 다르다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

약물력: 이름·시작일·중단일과 전신 증상을 확인한다

처방약·한방약·민간요법·보조식품·외용제까지 포함한다

1 **발병일·경과**

발진의 시작과 지속·일시성, 악화 속도, 재발 여부

2 **전신 증상**

발열·장기 침범의 징후와 피부 이외 증상

3 **모든 복용 약**

병원 처방약과 다른 기관의 약을 함께 확인

4 **비처방·국소제**

한방·민간요법·건강보조식품·피부와 점막 외용제

5 **점막·피부**

구강·안구·생식기 점막, 표피 박리, Nikolsky 징후

6 **기본 진찰**

좋은 조명에서 전신 시진과 촉진, 분포·배열 기록

임상 연결 · 처방약·한방약·민간요법·보조식품·외용제까지 포함한다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

DRESS: 발열·발진·내부장기 침범의 조합

피부가 보여도 간·콩팥·혈액 소견을 함께 평가한다

세 가지 주요 증상

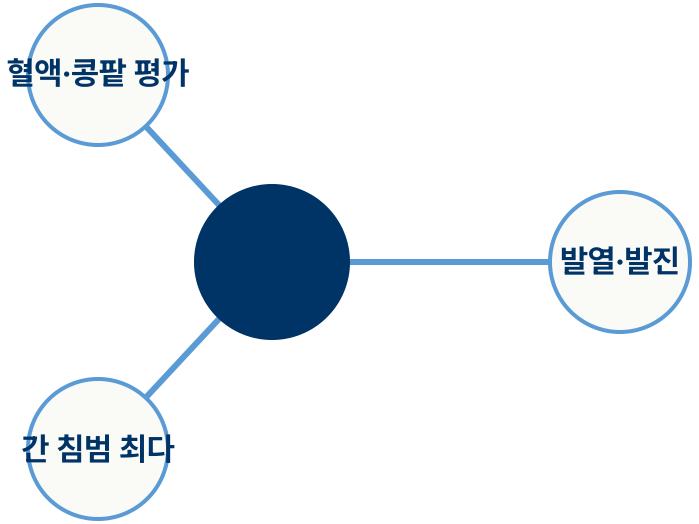
발열, 발진, 내부장기 침범. 발진은 홍역모양에서 심한 피부반응까지 다양하며 간 침범이 가장 흔하다.

동반 소견

림프절병증, 호산구증가 또는 이상림프구가 관찰된다. HHV-6 등 바이러스 재활성화가 관여한다.

검사와 경과

원인 약물 즉시 중단 후 혈액·간기능·크레아티닌 검사를 시행한다. 중단 이후에도 악화 가능성을 염두에 둔다.



진단과 평가의 연결 임상 소견을 연결한 도식

설명 도식 · 피부가 보여도 간·콩팥·혈액 소견을 함께 평가한다

임상 연결 · 피부가 보여도 간·콩팥·혈액 소견을 함께 평가한다

DRESS 원인약물: 항경련제 외 약물도 포함한다

방향족 항경련제 사이 교차반응이 강의에서 강조되었다

방향족 항경련제

Phenytoin, phenobarbital, carbamazepine, primidone. 특히 phenytoin·phenobarbital·carbamazepine 간 교차반응을 설명했다.

그 밖의 항경련제

Lamotrigine도 원인이 된다. 약물명을 확인하고 노출 후 2~8주의 시간 관계를 검토한다.

다른 주요 약물

Sulfonamide, dapsone, allopurinol, minocycline, piroxicam, terbinafine을 교재에서 제시했다.

임상 연결 · 방향족 항경련제 사이 교차반응이 강의에서 강조되었다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

강의 증례: carbamazepine 사용 4주 후 발진

안면부종·전신 발진·간수치 상승을 보인 소아 증례

1

약물 노출

Carbamazepine 사용 후 4주에 반응이 나타났다.

2

임상·검사

전형적인 안면부종과 전신 발진, 간수치 상승이 동반되었다.

3

원인 약물 중단

중단 후에도 병변은 2주 이상 지속되었다.

4

추적 경과

대증 치료를 하며 서서히 호전되었다. 중단 직후 호전을 전제하지 않는다.

임상 연결 · 안면부종·전신 발진·간수치 상승을 보인 소아 증례

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

DRESS에서 원인약제 중단과 장기 평가를 서두른다

단순한 발진 치료로 끝내지 않는다

즉시 중단·의뢰

약물 복용력에 발열·광범위 발진이 동반되면 약물 과민증후군과 SJS/TEN을 의심하고 즉시 의뢰한다.

검사

혈액검사, 간기능검사, 크레아티닌 검사가 필수다.
호산구증가·이상림프구와 장기 침범을 함께 확인한다.

유발검사

교재는 전신유발검사에 대해 반응의 심각성을 고려해 주의하도록 설명한다. 중단 후에도 병변과 전신 경과를 추적한다.

임상 연결 · 단순한 발진 치료로 끝내지 않는다

SJS / TEN: 표피 박리 면적에 따른 같은 스펙트럼

체표면적 기준은 발진 전체가 아니라 표피 박리 면적이다

SJS

표피 박리 체표면적 <10%. 국한 부위의 병변이 융합한다.

SJS/TEN overlap

표피 박리 체표면적 10~30%의 중첩 구간이다.

TEN

표피 박리 체표면적 >30%. 강의에서는 사망률이 높은 질환으로 설명했다.



설명 도식 · 체표면적 기준은 발진 전체가 아니라 표피 박리 면적이다

임상 연결 · 체표면적 기준은 발진 전체가 아니라 표피 박리 면적이다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

SJS / TEN: 급격한 확산·점막 침범·Nikolsky 양성

약물·감염 관련 급성 피부점막반응 — 여성에서 약 2배

전구기·확산

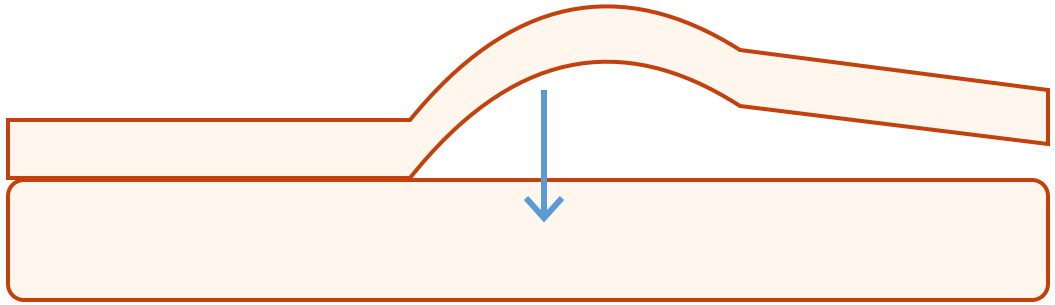
발열·인후통·근육통 같은 전구 증상이 1~14일 선행할 수 있다. 얼굴·목·흉부에서 시작해 급격히 확산한다.

점막·피부

약 90%에서 구강·안구·생식기 점막을 침범한다. Nikolsky 징후 양성, 교재는 4~5일에 병변이 최대가 된다고 제시했다.

의뢰

표피 박리·점막 침범은 즉시 의뢰해야 할 신호다. 원인약제를 찾아 즉시 중단한다.



표피 박리 | 피부점막반응 | 즉시 중단·의뢰

설명 도식 · 약물·감염 관련 급성 피부점막반응 — 여성에서 약 2배

임상 연결 · 약물·감염 관련 급성 피부점막반응 — 여성에서 약 2배

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

SJS / TEN 치료의 첫 단계는 원인약제 중단이다

강의에서 제시한 치료 핵심과 합병증 범위

즉시

원인약제 중단

교재·강의는 조기 중단에 따른 매일 사망위험 30% 감소를 소개했다.

20~70%

안과 합병증

안과 협진이 필수이며 점막 침범을 적극 확인한다.

집중치료

심한 피부 반응

중증에서는 수분·전해질 관리 등 화상센터 수준 치료가 필요하다.

교재가 제시한 치료 논점

고용량 methylprednisolone 1~2 mg/kg에 대해서는 논란이 있다고 표기했다.

외래 판단의 중심

원인약제 중단, 급성 피부점막반응 인지, 신속한 상급기관 의뢰와 안과 협진으로 연결한다.

임상 연결 · 강의에서 제시한 치료 핵심과 합병증 범위

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

DRESS와 SJS / TEN을 구분하는 임상 축

서로 다른 시간·장기 소견을 비교하되 중단·의뢰를 지연하지 않는다

판단 축	DRESS	SJS / TEN
발생 시점	약물 투여 후 2~8주	약물 노출 후 4~30일
주요 양상	발열·발진·내부장기 침범	급성 피부점막반응·표피 박리
동반 소견	간 침범, 림프절병증, 호산구증가/이상림프구	약 90% 점막 침범, Nikolsky 양성
처음 할 일	원인약물 중단, 혈액·간기능·크레아티닌	원인약제 중단, 즉시 의뢰, 안과 협진
경과·치료	중단 후에도 악화·지속 가능	심한 경우 화상센터 수준 집중치료

> 임상 연결 · 서로 다른 시간·장기 소견을 비교하되 중단·의뢰를 지연하지 않는다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

아나필락시스: 발진에 호흡·순환 이상이 겹칠 때

지연성 약물반응과 구분해 즉시 응급 처치한다

피부·호흡

전신 두드러기·맥관부종과 기관지경련·호흡곤란이 동반될 수 있다.

순환·전신

혈압강하·빈맥, 복통·오심·구토·설사, 의식소실을 포함한 전신반응이다.

시간·원인

대개 30분 내 발생, 강의는 24시간 내 소실을 설명했다. 페니실린·조영제·혈장제·아스피린, 면역·비면역 기전 모두 가능하다.

일차 치료

Epinephrine IM이 일차 치료다. 응급 처치가 늦거나 제대로 시행되지 않으면 생명을 위협한다.

임상 연결 · 지연성 약물반응과 구분해 즉시 응급 처치한다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

외래에서 놓치지 않을 마지막 여섯 가지

임상 징후를 행동으로 연결한다

1. **약물 노출을 시간축으로**
   처방·비처방·외용제를 모두 확인
2. **발열·광범위 발진**
   DRESS와 SJS/TEN을 의심하고 즉시 의뢰
3. **DRESS의 장기 침범**
   간·콩팥·혈액 검사와 중단 이후 경과 관찰
4. **표피 박리·Nikolsky 양성**
   SJS/TEN 의심
5. **구강·안구·생식기 점막**
   약 90% 점막 침범과 안과 합병증 인지
6. **호흡곤란·저혈압 동반**
   아나필락시스: epinephrine IM과 응급 처치

임상 연결 · 임상 징후를 행동으로 연결한다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

강의 내용을 외래 진료의 흐름으로 연결합니다

발생 시점·장기 침범·표피 박리에서 즉시 중단과 의뢰까지

학습의 출발점

발생 시점·장기 침범·표피 박리에서 즉시 중단과 의뢰까지
중증 약물이상반응: DRESS와 SJS/TEN을 놓치지 않는 외래 판단

PHONE

031-893-4560

HOURS

평일 08:30~18:30 · 토 08:30~13:30

ADDRESS

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호

SPECIALTY

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

의료진 학습자료 다시 보기

광교바른내과 · 의료진 학습자료